جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ايمان عطا حبيب حرز
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** اخري **العنوان :** بنى خالد
رقم البطاقة : 26908232400684 **رقم التليفون :** 01200388861 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 23-08-1969 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: ايمان عطا حبيب حرز
National ID: 26908232400684

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

Report Number: m1883

اسم المريض	: ايمان عطا حبيب	النوع	: Female
السـن	: 53 Y	العنوان	: القاهره
تاريخ اخذ العينة	:	تاريخ استلام العينة	: 13/07/2023 11:08
طالب التحليل	: مستشفى القبطى مؤسسة علاجية	تاريخ التقرير	: 17/07/2023 12:26
عناية	: مستشفى القبطى مؤسسة علاجية		

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

ER &PR & HER2 neu & Ki67 (ER&PR: Harvey scoring system -Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample recieved was treated by: - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody.- CONFIRM anti-progesterone receptor(PR) (IE2)Rabbit monoclonal primary antibody.
Sample recieved was treated by : -VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX / XT .
Sample recived was treated by :- CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbeit monoclonal primary antibody.

Result :

ER: moderate nuclear staining of > 60 % of tumour cells
PR: strong nuclear staining of > 60 % of tumour cells
HER2/neu protein over expression : strong continuous membrane staining of > 10 % of tumor cells.
Ki67 :positive nuclear staining of > 20 % of tumour cells

Referal Lab :

Comment :

Conclusion :

ER: POSITIVE (SCORE 7 / 8)
PR: POSITIVE (SCORE 8 / 8)
HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : POSITIVE (SCORE 3+)
#Ki67: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS > 20 % .

Pathologist: د/تريزا ماهر

Lab Director: د/تريزا ماهر

وزارة الصحة
الإدارة المركزية للمعامل

19 El-sheikh Rehan Street, Abeldeen, Cairo
Tel.(165)7948544 -7950096 Fax. (202)7948544
Mobile . 01144297292
website:http://www.healthlabs.net
email:pathologychl@yahoo.com
facebook. قسم الباثولوجى - الادارة المركزية للمعامل

This Test Is Not Accredited By EGAC Nor Recognized By ILA

يتم الاحتفاظ بأصل العينة لمدة 30 يوم من تاريخ استلامها

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Name: ايمان عطا حبيب حرز **MR. :** 2088	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was diagnosed with postmenopausal left breast cancer, having undergone left modified radical mastectomy on 25/4/2023. Pathology revealed a T3 N3 (11/20) M0 tumor that was estrogen receptor (ER) 8/8 positive, progesterone receptor (PR) 8/8 positive, HER2 2+ (with 3+ on repeat), and a recurrence score of 4. Adjuvant therapy included THP followed by PHESGO, which was completed in September 2024, and subsequently the patient was placed on ZOMETA and FEMARA starting in January 2024.

The current regimen consists of FEMARA with supportive care for a planned duration of three months, with the next clinic visit scheduled for 26/8/2026.

تحريرا في ,

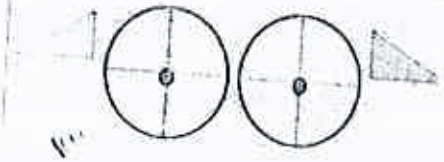
التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : dina makram

يعتمد ,

MDT form

tient ID:
lame : ايمان عطا حبيب حرز
Sex: Female
3- Medical number: 83166106
Old Med : 3727-2023
number: 26908232400684
Patient Age : 54 Y



ily history	Family History	Phone	Phone 01200388861 01019927054	BMI	BMI	REASON OF MDT	REASON OF MDT REMOT
ital status	Marital Status	NRS Score	NRS Score	GROUP	GROUP H	Date of MDT	Date Of MDT 2023-10-08
norbidity	Co Morbidity	Menopausal status	Menopausal Status PERIMENOPAUSAL				

Clinical data

ast Imaging :

Mets Workup :

	ER:	PR:	Her 2 Neu :	SISH :	KI67 :
C DIAGNOSIS	7/8 ER COMMENT:	8/8 PR COMMENT:	3 Her 2 Neu COMMENT:	SISH COMMENT :	30

N	M
3	0

nomammography

reast u/sn 18/4 : lt breast mass 58 x 30 mm BIRADS 5

TIENT HISTORY

T MRM + ALND 5/2023:PT3 PN3
N 11/20
ET CT 25/5:-ve
ceived AC x3 then taxotere 1 cycle 22/8

MDT OUTCOME & PLAN

OUTCOME & PLAN

O CONTINUE FOR 3 MORE CYCLES OF TAXOTERE +HERCEPTIN +PERJETTA FOR 17 CYCLES THEN ORT THEN HORMONAL TREATMENT

SIGNATURE

EDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY د/ حنان عزت	RADIOLOGY	RADIOLOGY د/ امل هجو
URGERY	SURGERY	PATHOLOGY	PATHOLOGY
sychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition

nank

الدرة
ALDURRA
للأشعة والتحاليل
SCAN&LABS

Name: Eman Atta Habib	Date: 25/5/2023
Referring Phys. Nagy samy Gobran	ID: 4786

Whole body PET/CT EXAMINATION:

Clinical History:

- 53 years old Female patient
- Left Breast cancer managed by mastectomy.
- PET/CT requested for assessment.

Technique:

- For the aforementioned patient we have done a total body PET scan one hour after IV injection of 370 MBq of 18 F-FDG. MSCT was performed using GE Discovery IQ simultaneously and used for attenuation correction, anatomical localization and diagnosis. Max. variant of SUV; a Semi-quantitative analysis would be done for selected ROI.s and the normal threshold is < 2.5.

Previous PET/CT studies:

- None

Report:

- *Evidence of left mastectomy with non FDG avid seroma formation averaging 6.5x2.5cm*
- No abnormal FDG uptake is seen to suspect residual neoplastic disease.

Head and Neck:

- Normal diffuse brain activity with no hypermetabolic brain lesions.
- Physiologic FDG uptake is seen in the nasopharynx, oropharynx, salivary glands and larynx, showing normal appearance.
- Physiologic FDG uptake is seen in submandibular and parotid salivary glands, showing normal appearance.
- Otherwise, Normal size, enhancement & symmetrical appearance of thyroid glands with no FDG avid lesions detected.
- Normal appearance of the neck muscles & vessels.
- No hypermetabolic cervical lymphadenopathy detected.
- No FDG avid neck soft tissue mass lesions.

Chest:

- No hypermetabolic mediastinal or axillary lymphadenopathy.
- No FDG avid lung nodules or masses detected.
- No metabolically active pericardial or pleural lesions detected.
- Physiologic FDG uptake is noted in the heart, showing normal shape.

Abdomen and Pelvis:

- Physiologic diffuse FDG uptake is seen over average sized liver with homogenous parenchymatous texture. No FDG avid focal lesions detected.

www.AlDurraScan.com
010 500 300 38
010 500 300 39
02 247 230 86
02 247 230 66
Info@aldurrascan.com
8 مصطفى النحاس بجوار مدرسة المنهل - الحى التاسع - مدينة نصر

PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]

- Patent homogenously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicle dilatation.
- Physiologic diffuse FDG uptake is seen over average.size spleen with homogenous parenchymal texture and no FDG avid focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Physiologic FDG excretion is seen in the kidneys and bladder.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals with no FDG avid lesions detected.
- No hypermetabolic abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No FDG avid ascites or abdominal collections noted.
- *Cholecystectomy clips with clear surgical bed*

Musculoskeletal:

- Normal FDG activity is seen over the axial skeleton. No focal active sclerotic or lytic bone lesions detected.

Conclusion:

- **Negative study for FDG avid residual neoplastic disease or active metastatic deposits.**

THANK YOU FOR REFERRAL,

Dr Marwan R. Elsokkary, FRCR

MRI - Alexandria uni

A.prof Omnia Talaat, MD

NCI - Cairo University

www.AlDurraScan.com

010 500 300 38
010 500 300 39

02 247 230 86
02 247 230 66

Info@aldurrascan.com

8 مصطفى النحاس بجوار مدرسة المنهل - الحى التاسع - مدينة نصر

PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]

Dr.
Elia Anis Ishak
M. Sc. Ph. D. Pathology - Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow, Armed Forces Institute of Pathology , USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Dr.
Shady Elia Anis
M. Sc. MD Pathology , Ass. Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow , Mass General Hospital , Harvard , USA
Member , United States Canadian Academy of Pathology

Patient Name : ايمان عطا حبيب
Age : 53 Y : 8 M : 1 D
Referred By Prof. Dr. : فادى ناجى
Clinical Diagnosis : Breast mass
Nature of Specimen : Left Modified Radical Mastectomy
Receiving Date : 2023-04-25

Analysis ID : 742294
Gender : Female
Patient ID : 568768

PATHOLOGY REPORT

Gross :

Left Modified Radical Mastectomy measured 25x14x6.5 cm with skin ellipse measured 18x10 cm. Nipple and areola are free. Cut section revealed mass with firm gritty cut section and ill defined borders, measured 7.5x5.8x3.5 cm.
The mass located 2 cm from nipple and 0.7 cm from skin.
All surgical margins are free. Least margin is 1.5 cm deep.
Dissection of the axilla revealed 20 lymph nodes, the largest measured 2.5x1.4 cm with grayish cut section.

Microscopic :

Sections examined from the specimen received revealed breast tissue showing tumour tissue formed of irregular groups of malignant ductal cells showing marked nuclear pleomorphism, hyperchromasia. There is poor attempt at tubular formation with predominent micropapillary pattern.
There is moderate number of mitotic figures
There is moderate desmoplasia and focal tumoral necrosis.
There is peritumoural lymphocytic infiltration around 10%.
Lympho- vascular space invasion is present.
Perineural invasion is present.
No intraductal component.
Sections from the nipple and areola are free.
Surgical margins are free.
Sections examined from the axillary nodes revealed metastatic deposits in 11 out of 20 nodes with no capsular infiltration.

DR ELIA ANIS LABS
عمارة رمسيس - بلوك أ - ميدان رمسيس - الدور السادس و السابع
تليفون : ٠١١٤٣٠٧٣٢٦٥ - ٢٥٧٤٤٧٤٢ - ٢٥٧٧٣٢٥٣ - ٢٥٧٩٠٩٣٥

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Dr.
Elia Anis Ishak
M. Sc. Ph. D. Pathology - Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow, Armed Forces Institute of Pathology , USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Dr.
Shady Elia Anis
M. Sc. MD Pathology , Ass. Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow , Mass General Hospital , Harvard , USA
Member , United States Canadian Academy of Pathology

Patient Name : ايمان عطا حبيب
Age : 53 Y : 8 M : 1 D
Analysis ID : 742294
Gender : Female
Referred By Prof. Dr. : فادى ناجى
Clinical Diagnosis : Breast mass
Nature of Specimen : Left Modified Radical Mastectomy
Receiving Date : 2023-04-25
Patient ID : 568768

PATHOLOGY REPORT

Diagnosis :

Breast mass, Modified Radical Mastectomy, INVASIVE MICROPAPILLARY CARCINOMA, NO INTRADUCTAL COMPONENT, FREE SURGICAL MARGINS, AXILLARY LYMPH NODE METASTASIS , L.N. 11/20 WITH NO CAPSULAR INFILTRATION.
- TUMOR STAGE: pT3 pN3a

Prof. Dr. Shady Elia Anis

Prof. Dr. Elia Anis Ishak

This report is electronically signed , any abrasion or modification would render it void .

DR ELIA ANIS LABS
عمارة رمسيس - بلوك أ - ميدان رمسيس - الدور السادس و السابع
تليفون : ٠١١٤٣٠٧٣٢٦٥ - ٢٥٧٤٤٧٤٢ - ٢٥٧٧٣٢٥٣ - ٢٥٧٩٠٩٣٥

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]